健康是“1”

身心一体、整全健康

——如皋市实验初中健康学校课程重构实践总结

案例实践单位

如皋市实验初中

全国教育科学规划一般项目 BEA230076

青少年情感教育的内涵、体系和范式研究

项目负责人：丁锦宏

2026年10月

一、案例定位

本案例以全国教育科学规划一般项目“青少年情感教育的内涵、体系和范式研究”（BEA230076，负责人：丁锦宏）关于情感教育的主体生成、关系支持和行动实践的认识为分析框架，以如皋市实验初中为实践单位，总结学校落实“健康第一”的课程重构经验。

案例的重点不是减脂餐、体育比赛、心理辅导或志愿服务中的某一项，而是学校如何把健康从分散的专项工作变成可进入课表、可持续实施、可追踪评价的育人结构。学校将“健康是 1，其他是后面的 0”的价值判断转化为“身心一体、整全健康”的办学行动，从学生真实健康问题出发，形成课程、活动、数据、评价和协同机制之间的闭环。

二、问题从哪里来

初中阶段是学生身体发育、自我认同和社会交往迅速变化的时期，也是近视、超重肥胖、体态问题、睡眠不足、考试焦虑和情绪困扰容易叠加的时期。学校原有健康工作存在三类结构性不足。

第一，健康被分割。体育教师负责体测，心理教师负责个案，食堂负责供餐，班主任主要对成绩负责。每个部门都在做事，但学生获得的健康支持是碎片化的。

第二，健康被理解为纠正。面对超重肥胖、视力下降或心理困扰，学校容易采用统一加练、集中讲座和家长告知，把健康变成对少数“问题学生”的矫正，忽视了全体学生自我管理能力的形成。

第三，健康工作缺少课程与证据。活动能够形成短期声势，却难以回答“学生是否每天有运动时间、是否学会选择食物、是否知道如何求助、支持是否真正到达需要的人”。如果评价只看是否开展活动，健康就很难成为学校日常运行的一部分。

项目研究给出的关键启发是：健康不是被动服从的外部要求，而是学生在安全关系、真实任务和持续反馈中形成的自我认识与自我管理。学校因此没有继续叠加活动，而是用“健康逻辑”重构课程和学校治理。

三、实践模式

学校形成“一体三维四环”健康学校课程育人模式。

（一）“一体”：身心一体、整全健康

“一体”指身体健康、心理健康和社会适应不是三个彼此分离的领域。运动可以改善情绪与自我效能，同伴关系影响求助意愿，睡眠、饮食和学业压力共同作用于身体状态。学校因此不把健康工作交给单一部门，而是让体育、心理、德育、总务、医务和家庭共同承担。

（二）“三维”：三类课程

1. 健康身体课程。 聚焦体能、视力、体态三个最突出的身体问题。体能课程实行每天一节体育课，采用“3+2”结构：三节强基、两节拓展，开展“月月有比赛”和课间微运动；视力课程改善照明、课桌椅和户外远眺条件，建立电子档案；体态课程把减脂餐、营养点餐、脊柱筛查、单杠悬垂、靠墙站立、踏板操和形体操结合起来。

2. 健康心理课程。 形成预防、发展、干预三级方案。预防性课程面向全体，落实每天润心广播、心理晴雨表、每周微课、每月沙龙、每学期普查和全员导师制；发展性课程通过“五有好少年”成长规划和“成长锦盒”发现优势；干预性课程通过 ABC 分级关爱、跨部门联防和“未来可期”课程，为厌学、消沉或心理困扰学生提供个别化支持。

3. 健康社会适应课程。 从“会相处—能融入—愿担当”逐层推进。学生通过师友成长共同体、暖言善行、班级文化共建、班级树和班级花形成同伴支持；通过“满天星”志愿服务和“小委员提案”进入真实公共生活，每生每学期完成不少于8次、10小时志愿服务。

（三）“四环”：监测诊断—课程供给—日常行动—评价改进

学校将体测、视力、脊柱、饮食、运动和心理筛查数据汇入“健康画像”，用于发现趋势和调整课程，不以公开排名制造压力。课程供给强调可排入课表、有固定时段和责任人；日常行动关注学生能否持续运动、合理选择饮食、主动求助和参与集体；评价改进通过“三元五维”评价、“自育积分”和“绿色质量”考核，把学生变化、教师责任和学校治理连接起来。

四、改革是怎样推进的

第一阶段：从一个真实数据开始

学校将273名超重肥胖学生纳入减脂餐和健康监测，逐一提供减脂窗口、营养讲座、体脂秤和挑战卡，建立选餐与体重记录。一周后，减脂窗口使用明显增加；一学期后，纳入管理的273名学生平均减重12.8斤。公开媒体同期以BMI超过28为口径报道341名学生，这一筛查数字与273名持续管理对象之间是什么关系，仍需用原始体测与入组台账核实。

这一试点的价值不在于减重本身，而在于学校看见了数据背后的生活场景：学生会选择什么食物，家长是否理解饮食结构，运动时间是否被挤占，教师能否把健康建议转成日常行动。

第二阶段：从单项服务转为三类课程

减脂餐如果只停留在食堂，容易成为一次性项目。学校随即研发营养点餐系统，提供菜品营养与热量信息；把单杠悬垂、靠墙站立、踏板操和形体操纳入体育与课间；把心理晴雨表、全员导师和“未来可期”课程纳入心理支持；把志愿服务和班级共建纳入社会适应课程。健康由此进入学生的每一天。

第三阶段：从部门执行转为学校治理

学校将“健康第一”写入章程和办学计划，建立健康促进相关组织，推动体育、心理、德育、总务、医务共同履职；联合市场监管、卫生防疫和家长代表组建膳食委员会；联合公安、民政等部门形成关爱网络。健康不再只是某个教师的额外工作。

第四阶段：从活动检查转为证据改进

学校建立视力与脊柱档案、体测记录、心理筛查、选餐记录、运动参与和志愿服务记录，形成“健康画像”；通过“三元五维”评价和“绿色质量”考核，检查健康是否真正进入课程、课堂和日常管理。课时安排、作息和食堂管理接受家长与社会监督。

五、关键变化

（一）学生从“被检查”走向“能管理”

学生通过体脂秤、点餐系统、运动记录和挑战卡看到自己的变化，通过心理晴雨表学会表达和求助，通过师友共同体和志愿服务获得归属与责任。健康不再只是体检表上的结果，而是每天可以作出的选择。

（二）教师从“各管一段”走向共同负责

体育教师获得心理与营养支持，班主任能使用健康画像理解学生，心理教师与全员导师形成分级支持，总务和食堂把食品安全、营养结构纳入课程。专职分工仍然存在，但共同目标已经形成。

（三）学校从“开展健康活动”走向“建设健康课程”

健康身体、健康心理、健康社会适应三条课程线进入学校课程结构，健康指标进入教师和学校评价，形成了课程、时间、人员、数据和协同机制的制度保障。

六、可核查的成效

学校现有材料可以支持以下事实：

- 学校将273名超重肥胖学生纳入减脂餐与数字化管理；一学期平均减重12.8斤。公开媒体另以BMI超过28为口径报道341名学生，二者关系待原始台账核实。
- 男生引体向上一年平均由0.8个提高到接近2个，平均增加1.8个。
- 统筹课间、午间和大课间后，每日校内有效运动时间增加40分钟。
- 建立覆盖全校学生的视力电子档案和脊柱健康档案。
- 形成预防、发展、干预三级心理课程，学校材料记录“未来可期班”学业困难与心理困扰学生转化率为90%。
- 每名学生每学期完成不少于8次、10小时志愿服务。
- 学校党总支书记裴友军撰写的《健康学校建设的问题检视与实践探索》发表于《江苏教育研究》2026年第8期第18—22页。
- 2026年7月，校长以“一个都不能少：教育最动人的模样”在省级教育交流中报告健康学校建设。
- 央广网、南通日报等媒体对学校减脂专窗和健康学校建设做法作出报道。

七、证据边界

“平均减重12.8斤”只对应2023年纳入管理的273名超重肥胖学生及其一学期监测，不等同于全校学生平均减重。引体向上数据只对应男生群体，不等于全体体能全面提升。每日增加40分钟是校内有效运动时间的制度性增加，不等于每个学生都达到相同运动量。

“未来可期班”转化率90%目前来自学校材料，正式对外使用前应补齐样本数、分母、随访时点和“转化”的操作定义。媒体和期刊发表证明学校实践被看见，但不能替代学生健康结果。学校目前没

有经签字盖章的外单位正式采用证明，因此案例不虚构外部推广单位，也不把公开课、跟岗交流或集团教研写成区域整体采用。

八、可迁移条件

外校借鉴时，关键不是复制减脂餐或某套操，而是保留以下六个条件：

1. 健康第一进入学校章程、课程表和年度计划；
2. 体育、心理、德育、总务、医务有共同负责人和协商机制；
3. 健康数据有明确采集目的、使用边界和隐私保护；
4. 学生、教师和学校三层评价共同关注过程与结果；
5. 家庭、社区、医院和相关部门形成稳定协同；
6. 不以短期减重、体测分数或学业分数替代完整健康判断。

九、下一步建议

1. 为273名学生的减重数据补齐统计起点、结束点、缺失值和测量方式。
2. 明确“未来可期班”转化率的样本数、分母、随访周期和评价标准。
3. 汇总近年的近视率、体质优良率、心理筛查和运动参与趋势，区分学校自报与第三方监测。
4. 对公开传播中的学生照片、姓名和家庭信息完成授权与脱敏。
5. 由真实使用单位提供写明时间、使用方式、调整和效果的正式采用证明，再进入附件1推广单位栏。